

NS 22231568614

GERALDO DE FARIAS CAMPOS

IDADE: 76	PESO: 67	ALTURA: 167	PROFISSÃO: (Superv. Urinagem) Aposentado
SINTOMAS: cansaço.			
QUEIXAS: após almoço cansaço / dorme na cadeira do papai.			
MEDICAMENTOS: Fluorexemida / entrueto / AAS / carvedilol / glifage			
Zetsin / Vastarel / fardiance			
MÉDICO: Dr. Smauel Coppio / José Eduardo			
EXERCÍCIO FÍSICO: só dia a dia trabalho na roça.			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 19			
HORA QUE DORME: 21:30		HORA QUE ACORDA: 5:30	
COCHILO ☒ SIM () NÃO		DORME ACOMPANHADO () SIM ☒ NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA ☒ NÃO			
FUMO () SIM () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal		BANHEIRO: 2X	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: 34	
OVERLAP: não	MALLAMPATI: IV	IAH: 28.3	SPO2: 79% 6cmH ₂ O 2º PSG
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: IAM			
CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não			
COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA		() CARDÍACA 2 stents ICC	
() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA		() OUTROS	
28/11 P= automática (P= 4-8 cmH ₂ O / máscara) 23 Evoca (m) full face			

05/12 P= 7.9
23 IAH= 3.7 melhora da disposi
m. de uso: 7h30' ção.
Orçento o uso de dia + bem. Jua

14/12 P= 8.0 cmH₂O ↑ p/ 8.6 cmH₂O
23 IAH= 5.6 l/min Jua.
m. de uso: 8hr

04/01/24 P= 8.6 cmH₂O dorme inclinado poltrona
IAH= 4.2 l/min
m. de uso: 8hr
fuga 3l/min

05/02 Compreou o CPAP (entregou CPAP)
24 P= 8.6 cmH₂O
IAH= 6.3 l/min
m. de uso: 7h40' Jua.
Fuga= 2.7 l/min

22/03 P= 9 cmH₂O Bem adaptado.
24 IAH= 4.5 l/min
m. de uso: 8hr
Fuga= 1.9 l/min Jua

22/02
24

P = 9 cmH₂O

IAH = 4,5

m. de uso: 8h 13 min

Bem adaptada

matéria

26/04
24

P = 9 cmH₂O

IAH = 4,2

M. de uso = 8h

+ troco o filtro

lua.

26/06
24

P = 9 cmH₂O

m. de uso: 8h 25'

IAH = 6.0 e/h

Fuga = 2.6 lpm

lua.

07/11
24

P = 9.8 cmH₂O

IAH = 7.8 e/h

M. de uso = 7h 35'

Fuga = 2.7 lpm.

Relata sentir fadiga
durante o dia p/ conver-
sar.

lua cláudio

21/02
25

P = 9.8 cmH₂O

IAH = 7.3 e/h

M. de uso = 7h 46'

fuga = 1.6 lpm.

30/12/23 fez a impl. marca

lua

23/05/25

P = 9.8 cmH₂O

IAH = 10 e/h

m. de uso = 8h 29 min

fuga = 3.6 l/min

domindo bem ; já estava um pouco deslig
mantendo.

↑ P: 10.2 cmH₂O

Silvia

marco reformo 15 dias

06/06
25

P = 10.2 cmH₂O

M. de uso = 8h 30'

fuga = 3.2 lpm

↑ P_i = 6 cmH₂O

lua.

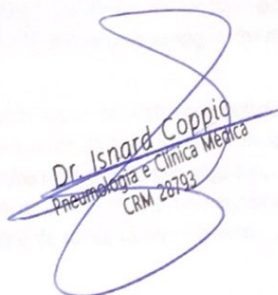
Dr. Isnard Coppio
CRM 28793

Clínica Médica e Pneumologia

Geraldo de Farias Campos

Encaminhamento para uso de cpap

28/08/2023


Dr. Isnard Coppio
Pneumologia e Clínica Médica
CRM 28793

Rua Dr. Ivan de Souza Lopes, 94 - Centro
Tels. 3922-4627 3922-7721 Fax: 3942-9255
São José dos Campos - SP

Nome: GERALDO DE FARIAS CAMPOS

Data de Nascimento: 7-9-1947

IMC: 23,74

Sexo: Masculino

Data do exame: 19-07-2023

Peso: 67 kg

Altura: 1,68 m

Médico: DR. ISNARD COPPIO

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 19-07-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 539,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 41,0 e 173,0 minutos. O tempo total de sono foi de 398,5 min, eficiência de 73,9% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,6%; estágio N2: 56,0%; estágio N3: 18,3%; sono REM: 24,1%. O índice de despertares foi de 2,9/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 5,3/hora, sendo 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 35 hipopnéias. A SpO2 média foi de 95% e a mínima de 91%, permanecendo 0,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 57 - 74 bpm e NREM de 57 - 75 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (7), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latências para o sono prolongadas;
4. número de despertares breves normal;
5. registro de ronco durante o sono.

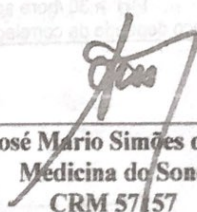
Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 6 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: GERALDO DE FARIAS CAMPOS
Data de Nascimento: 7-9-1947
IMC: 23,74
Sexo: Masculino
Data do exame: 30-05-2023

Peso: 67 kg
Altura: 1,68 m
Médico: DR. ISNARD COPPIO
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 30-05-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 551,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 21,5 e 95,0 minutos. O tempo total de sono foi de 351,5 min, eficiência de 63,7% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,3%; estágio N2: 55,6%; estágio N3: 16,8%; sono REM: 25,3%. O índice de despertares foi de 11,5/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 28,3/hora, sendo 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 165 hipopnéias. A SpO2 média foi de 91% e a mínima de 79%, permanecendo 10,5% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 49 - 70 bpm e NREM de 50 - 73 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (7), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N2 do sono NREM aumentada e porcentagem dos estágios N1 e N3 do sono NREM dentro da normalidade;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 28,3/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=79%);
5. latências para o sono normais;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

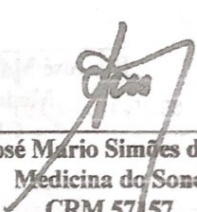
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.57